Latir

RECURSOS DE LIBRE USO EN PSICOONCOLOGÍA



GUÍA PARA EL CAMINO

# Cuidar a quien cura

Para equipos de salud que acompañan a personas con cáncer · guía y registro

## ¿Qué vas a encontrar acá?

**Para comprender**

Fatiga por compasión, burnout y satisfacción por compasión; el duelo de los profesionales; comunicar malas noticias y el equipo como sostén.

**Para completar**

Cómo estoy hoy, mis señales de alerta y un plan de cuidado personal y de equipo.

## ¿Cómo usarla?

1. Ábrela en el celular o la compu con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Lee la guía con calma, a tu ritmo. No hace falta leer todo de una vez: puedes volver cuando lo necesites.
3. Completa las hojas de registro tocando las opciones y escribiendo sólo lo que quieras.
4. Guarda los cambios. Si te sirve, compártela con tu equipo y úsenla en una reunión o un espacio de reflexión.

**Es tuya**

Es para ti y, si quieres, para tu equipo: oncología, hematología, enfermería, radioterapia, cuidados paliativos, residencias, trabajo social, voluntariado. Puedes completarla a solas o usarla como disparador en un espacio de equipo.

## ¿Para qué sirve?

- Ponerle nombre al desgaste que produce acompañar el sufrimiento.
- Distinguir el cansancio esperable de las señales de alerta.
- Reconocer también lo que nutre y da sentido a la tarea.
- Pensar el cuidado como responsabilidad del equipo, no sólo de cada uno.

**«Esperar que podamos estar inmersos cada día en el sufrimiento y la pérdida sin que nos toque es tan poco realista como esperar caminar por el agua sin mojarnos.»**

Rachel Naomi Remen

PARA COMPRENDER

# El costo y el sentido de cuidar

Acompañar a personas con cáncer expone todos los días al dolor, la incertidumbre y, a veces, la muerte. Ese contacto deja huella. No es falta de vocación ni de profesionalismo: es un efecto esperable de cuidar, que necesita ser cuidado.

### Fatiga por compasión

Charles Figley la describió como el desgaste por el contacto con el sufrimiento de otros: menos capacidad de empatía, irritabilidad, imágenes que no se van.

### Burnout

Christina Maslach lo definió por tres rasgos: agotamiento emocional, despersonalización (distancia o cinismo) y baja realización personal. Tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo.

### Satisfacción por compasión

Beth Hudnall Stamm señaló la otra cara: el sentido y la gratificación de ayudar. Cuidarla también protege.

### El duelo del profesional

Perder pacientes duele, aunque se espere. Kenneth Doka habló de duelos no reconocidos: los que no tienen lugar ni permiso para expresarse.

## Algunas señales

| En mí | En el equipo |
|---|---|
| Cansancio que no se va con el descanso. | Más conflictos, quejas o silencios. |
| Distancia emocional, cinismo o irritabilidad. | Bromas que lastiman o deshumanizan. |
| Dificultad para desconectar, insomnio. | Ausentismo, rotación, pocas ganas de reunirse. |
| Sensación de que nada alcanza. | Cada uno resuelve solo/a lo que duele. |

**Lo que me quedó resonando**

PARA COMPRENDER

# Herramientas para el día a día

## Comunicar malas noticias

El protocolo SPIKES (Baile y Buckman, 2000), conocido en español como EPICEE, ordena una de las tareas más difíciles de la oncología:

1. **Entorno:** un lugar privado, tiempo, sentarse, invitar a un acompañante.
2. **Percepción:** preguntar qué sabe o entendió la persona.
3. **Invitación:** cuánto quiere saber y cómo.
4. **Comunicar:** con palabras simples, de a poco, anticipando que es una noticia difícil.
5. **Empatía:** dar lugar a las emociones, nombrarlas, hacer silencio.
6. **Estrategia:** resumir y acordar los próximos pasos.

## El equipo como sostén

### Espacios de reflexión

Reuniones periódicas para hablar de lo que movilizan los casos, no sólo de lo técnico.

### Después de una situación difícil

Un breve encuentro para poner en palabras lo vivido y ver quién necesita algo más.

### Rituales de despedida

Un momento para recordar a los pacientes que fallecieron.

### Cuidar los límites

Pausas reales, turnos posibles, derecho a no estar disponible siempre.

**Lo que me quedó resonando**

PARA COMPLETAR

# Cómo estoy hoy

**En las últimas semanas…**

| | Nunca | A veces | Seguido | Siempre |
|---|---|---|---|---|
| Me siento agotado/a emocionalmente. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Me cuesta conectar con el sufrimiento de los pacientes. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Me llevo el trabajo a casa (en la cabeza o en el cuerpo). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Siento que mi trabajo tiene sentido. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cuento con alguien del equipo para hablar de lo que me pasa. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Mis señales de alerta**

- ☐ Irritabilidad
- ☐ Distancia o cinismo
- ☐ Más consumo (alcohol, medicación, pantallas)
- ☐ Ganas de dejar todo
- ☐ Insomnio
- ☐ Llanto o angustia
- ☐ Dolores o tensión física
- ☐ Aislamiento

**Una situación o un paciente que me quedó resonando**

**Notas para conversar**

PARA COMPLETAR

# Mi plan de cuidado

**LO QUE ME AYUDA A RECUPERARME**

**LO QUE QUIERO EMPEZAR O RETOMAR**

**LO QUE PODRÍAMOS HACER COMO EQUIPO**

**A QUIÉN SE LO VOY A PROPONER**

## Un límite que necesito cuidar

### Si ya no das más

El agotamiento sostenido no se resuelve sólo con voluntad. Si notas que no puedes desconectarte, que duermes mal hace semanas, que aumentó el consumo de alcohol o de medicación, o que aparecen ideas de hacerte daño, pide ayuda profesional. En Argentina puedes llamar al 135 (Línea de Salud Mental, gratuita, las 24 horas).

## Notas para conversar